

Hypertrophie de la prostate (BPH)

Information pour le patient · Pourquoi les symptômes urinaires apparaissent et comment les traiter

WARWIKI

Une prostate hypertrophiée — hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) — est une croissance non cancéreuse très courante de la prostate avec l'âge. La glande élargie comprime le canal urinaire et provoque des symptômes gênants. L'HBP n'est **pas** un cancer et n'en cause **pas**, et il existe de nombreux traitements efficaces, des changements simples aux médicaments jusqu'à la chirurgie.

À propos de cette affection

La prostate entoure la partie supérieure de l'urètre. En grossissant, elle comprime ce canal, provoquant des **symptômes du bas appareil urinaire (SBAU)** :

- Jet faible ou lent, hésitation, effort pour uriner, jet en stop-and-go
- Sensation de **vidange incomplète** et gouttes retardataires
- Mictions **fréquentes**, urgentes, et levers nocturnes (nycturie)

Pourquoi c'est important

L'HBP concerne surtout la **qualité de vie**, mais si elle est sévère, elle peut entraîner des infections urinaires, des calculs vésicaux, une rétention (impossibilité d'uriner) ou, rarement, une atteinte de la vessie et des reins. C'est votre niveau de gêne qui guide l'intensité du traitement.

COMPRENDRE LES TERMES

HBP

Hypertrophie bénigne de la prostate — une prostate élargie non cancéreuse.

SBAU

Symptômes du bas appareil urinaire — les troubles urinaires causés par l'HBP.

IPSS

Score symptomatique mesurant le niveau de gêne.

Rétention

Impossibilité d'uriner — nécessite une prise en charge urgente.

Alpha-bloquant / 5-ARI

Les deux grandes classes de médicaments contre l'HBP.

PSA

Dosage sanguin prostatique, souvent réalisé lors du bilan.

DOIS-JE OBLIGATOIREMENT ME FAIRE TRAITER ? Seulement si les symptômes vous gênent — des symptômes légers peuvent simplement être surveillés. Quand ils affectent votre vie quotidienne, le traitement progresse des mesures hygiéno-diététiques aux médicaments puis aux interventions. Il existe une option efficace à chaque étape. Le traitement dépend aussi du volume de votre prostate, que votre équipe évaluera.

Comment on l'évalue

- Un **score symptomatique** (IPSS) et une revue de vos apports liquidiens et médicaments
- Un toucher rectal, une **analyse d'urine** et souvent un **PSA**
- Un débitmètre urinaire et une mesure du résidu post-mictionnel

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Surveillance & hygiène de vie** — réduire les liquides le soir, limiter la caféine/l'alcool, rééduquer les habitudes vésicales.
- 2 **Médicaments** — un **alpha-bloquant** (soulagement rapide), un **inhibiteur de la 5-alpha-réductase** (réduit les grosses prostates), ou les deux ; parfois d'autres molécules.
- 3 **Options mini-invasives** — par exemple un lift uréthro-prostatique ou une thermothérapie à la vapeur.
- 4 **Chirurgie** — RTUP, HoLEP, Aquablation ou prostatectomie simple pour les grosses glandes ou en cas d'échec des étapes précédentes. Chaque option dispose de sa propre fiche.

Bon à savoir

- Le traitement de l'HBP dépend de **votre** niveau de gêne — rien n'est urgent sauf en cas de complications.
- Certains médicaments contre le rhume (décongestionnants) peuvent aggraver les symptômes.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une **impossibilité soudaine d'uriner** (vessie douloureuse et pleine) — urgent
- Du **sang dans les urines**, de la fièvre ou des infections répétées
- Des symptômes qui s'aggravent malgré le traitement

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'HBP est une hypertrophie bénigne courante de la prostate qui provoque des symptômes urinaires.
2. Le traitement est guidé par votre niveau de gêne : hygiène de vie, puis médicaments, puis options mini-invasives ou chirurgie.
3. Consultez en urgence si vous ne pouvez soudainement plus uriner, ou en cas de sang dans les urines, de fièvre ou d'infections répétées.